

Descrição do Exame de Polissonografia POLISSONOGRAMA BASAL

Nome: **EDSON FERNANDES LOBO**

Sexo: **Masculino**

Idade: **47 anos**

IMC: **37,42**

Peso: **112 kg**

Altura: **173 cm**

Data: **14-05-2024**

Médico Solicitante: **DR MARCELO SCAPUCCIN**

Comentários:

Exame realizado em Laboratório do Sono, em boas condições técnicas paciente em sono espontâneo noturno.

Os parâmetros foram registrados no sistema Brain Wave II (NeuroVirtual)®, utilizando os registros de EEG: F4-M1, C4-M1, O2-M1, F3-M2, C3-M2, O1-M2; EOG: bilateral; EMG: mentoniano/submentoniano; EMG: tibial bilateral; ECG: montagem D2 modificada; fluxo aéreo nasal por cânula de pressão e oronasal por termistor; esforço respiratório torácico e abdominal; saturação da oxi-hemoglobina (SpO2) por oximetria de pulso; sensor de ronco (microfone); posição corporal no leito.

Análise do exame foi realizada segundo a padronização do Manual da Academia Americana de Medicina do Sono 2012. (AAMS).

Exame iniciado 21h:57m:36s horas e concluído 06h:06m:47s horas. **A latência para início do sono foi de 69,5 minutos e a latência para o sono REM foi de 70,5 minutos.** O tempo total de sono foi de 489,2 minutos, com **eficiência do sono (TTS / TTR)* de 77,7%**. A distribuição do sono mostrou: **1,7%** de estágio N1, **46,9%** de estágio N2, **29,5%** de estágio N3 e **21,9%** de sono REM. No período total de sono permaneceu 39,7 minutos em vigília.

Ocorreram 70 despertares breves tendo o índice de **(8,6/hora)**.

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de 0/hora.

* (Classif. Patológica dos Movimentos Periódicos de Pernas - Walters e cols 1995; Leve: 5 a 24/hora; Moderado: 25 a 49/hora; Grave: > 50/hora).

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 82,8, a maior de 111 e a menor de 65.

O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de 47,7/h.

O índice de apneia/hipopneia foi de 47,7/h sendo 12,3 apneia/hora e 35,4 hipopneia/hora.

O número total de eventos respiratórios foi de 302, sendo 224 hipopneias, 78 apnéias obstrutivas, 0 apnéias centrais e 0 apnéias mistas e 0 RERAS.

O tempo médio das apnéias foi de 30,1 segundos, com duração máxima de 38,5 segundos.

A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 94%, sendo a saturação média de 94% e a mínima de 70%.

(*) TTS ⇨ Tempo Total de Sono **TTR** ⇨ Tempo Total de Registro



R: Major José dos Santos Moreira, 595 Centro Pindamonhangaba – SP
Tel (12) 3643-2044 – 36431889 www.institutodosonodovale.com.br

Resumo dos resultados

1. Aumento severo do Índice de apnéia/hipopnéia às custas de eventos respiratórios principalmente obstrutivos, associados a dessaturação da oxi- hemoglobina;
2. Presença de ronco;
3. Eficiência do sono reduzido;
4. Latência para o sono REM normal;
5. Aumento da porcentagem do sono de ondas lentas;
6. Índice de despertares breves dentro da normalidade.

Dr. José Roberto Scapuccin
CRM 31347
ORL/Medicina do Sono

Dr. Marcelo Scapuccin
CRM 139174
ORL/Medicina do Sono

Dr. Fabio Scapuccin
CRM 146278
ORL/Medicina do Sono

Paciente: **EDSON FERNANDES LOBO**
Data do Exame: 14-05-2024

Descrição do Exame de Polissonografia POLISSONOGRAFIA CPAP

Nome: **EDSON FERNANDES LOBO**

Sexo: **Masculino**

Idade: **47 anos**

IMC: **36,90**

Peso: **113 kg**

Altura: **175 cm**

Data: **04-07-2024**

Médico Solicitante: **DR MARCELO SCAPUCCIN**

Comentários:

Exame realizado em Laboratório do Sono, em boas condições técnicas paciente em sono espontâneo noturno.

Os parâmetros foram registrado no sistema Brain Wave II (NeuroVirtual)®, utilizando os registros de EEG: F4-M1, C4-M1, O2-M1, F3-M2, C3-M2, O1-M2; EOG: bilateral; EMG: mentoniano/submentoniano; EMG: tibial bilateral; ECG: montagem D2 modificada; fluxo aéreo nasal por cânula de pressão e oronasal por termistor; esforço respiratório torácico e abdominal; saturação da oxi-hemoglobina (SpO2) por oximetria de pulso; sensor de ronco (microfone); posição corporal no leito.

Análise do exame foi realizada segundo a padronização do Manual da Academia Americana de Medicina do Sono 2012. (AAMS).

Exame iniciado 22h:16m:58s horas e concluído 06h:00m:29s horas. **A latência para início do sono foi de 22,0 minutos e a latência para o sono REM foi de 87,0 minutos.** O tempo total de sono foi de 463,5 minutos, com **eficiência do sono (TTS / TTR)* de 76,7%**. A distribuição do sono mostrou: **2,8%** de estágio N1, **62,1%** de estágio N2, **18,9%** de estágio N3 e **16,2%** de sono REM. No período total de sono permaneceu 86,0 minutos em vigília.

Ocorreram 34 despertares breves tendo o índice de **(4,4/hora)**.

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de 0/hora.

* (Classif. Patológica dos Movimentos Periódicos de Pernas - Walters e cols 1995; Leve: 5 a 24/hora; Moderado: 25 a 49/hora; Grave: > 50/hora).

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 81,4, a maior de 110 e a menor de 65.

O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de 2,5/h.

O índice de apneia/hipopneia foi de 2,5/h sendo 0,0 apneia/hora e 2,5 hipopneia/hora.

O número total de eventos respiratórios foi de 15, sendo 15 hipopneias, 0 apnéias obstrutivas, 0 apneias centrais e 0 apneias mistas e 0 RERAS.

O tempo médio das apneias foi de 0 segundos, com duração máxima de 0 segundos.

A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 95%, sendo a saturação média de 95% e a mínima de 89%.

(*) **TTS** ⇒ Tempo Total de Sono **TTR** ⇒ Tempo Total de Registro

Resumo dos resultados

Polissonografia realizada com o uso de CPAP, onde resultados efetivos foram obtidos com a pressão de 13cmH₂O, mostrando:

1. Índice de apnéia/hipopnéia normal;
2. Presença de ronco;
3. Eficiência do sono reduzido;
4. Latência para o sono REM normal;
5. Diminuição da porcentagem do sono REM;
6. Índice de despertares breves dentro da normalidade.

Dr. José Roberto Scapuccin
CRM 31347
ORL/Medicina do Sono

Dr. Marcelo Scapuccin
CRM 139174
ORL/Medicina do Sono

Dr. Fabio Scapuccin
CRM 146278
ORL/Medicina do Sono

INDICADO POR: Sr ^a Lucia (Pcte)			
☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA			
NS			
EDSON FERNANDES LOBO			
IDADE: 48	PESO: 109	ALTURA: 173	PROFISSÃO: empresário - Hotelaria
SINTOMAS: Sonolência diurna / Acorda em apneia / RGE / Levedeira no mmi / Sonho ruim.			
QUEIXAS: Cansaço			
MEDICAMENTOS: Puroan / Insulma / Comodart / Defalecina (há tempo de uso)			
MÉDICO: Dr ^o Davi / Dr ^o Giovanna			
MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S (X) N			
EXERCÍCIO FÍSICO: 5x semana musculação			
HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: S (19) JANTAR: —			
HORA QUE DORME: 22		HORA QUE ACORDA: 07	
COCHILHO (X) S () N 2h		DORME ACOMPANHADO: () S () N () EVENTUALMENTE	
TEM FILHOS: () S () N		DORMEM NO QUARTO: (X) S () N	
		PET NO QUARTO: () S (X) N	
BEBIDA ALCOÓLICA: (X) S () X NA SEMANA () N raro esporadicamente por conta do ronc			
FUMO: () S () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: conta do ronc			
TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal		BANHEIRO/NOITE: 2 à 5x	
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: 4		CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:	
OVERLAP: não	MALLAMPATI:	IAH:	SPO2:
PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Sinusite / está esquecido / Dor ombro E Oncológico Negro			
CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA			
HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:			
COMORBIDADE: (S) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA			
(S) ORTOPÉDICA		(N) NEUROLÓGICA () OUTROS:	
POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S () N		SPO2 C/ CPAP: 13	PRESSÃO NO EXAME: 13
19/09 Avaliação			
25			